

QCM Gynéco-Obstétrique

Partie 1

Q1 : Dépistage trisomie 21, comment on fait ?

R : Mesure de la clarté nucale.

DPNI on fait si risque > 1/100 ?

En même temps que dépistage trisomie 21 → dépistage pré-éclampsie.

Q2 : 15SA, rhésus négatif, anti-D de 1 :128 (positif si > 1 :16). Déjà eu 3 grossesses dont 2 FC.

Réponse : détermination du groupe Rhésus du père de l'enfant. Contexte d'allo-immunisation, on est plus dans un contexte de prophylaxie car la patiente est déjà immunisée (risque d'hémolyse). Si père D- pas de risque, si père D+ alors on fait un génotypage fœtal (comme DPNI), si bébé D+ risque d'hémolyse et il faut surveiller si apparition d'une anémie (Doppler de l'a. cérébral moy = reflet de l'anémie sévère).

On donne le rophylac à 28SA, sauf si elle saigne on donne avant + 72h après la naissance.

Q3 : 3G1P, 16 SA. Grossesse par CS il y a 1 an. Hb 95g/l, pas reçu de fer.

R : Déficit en fer à mettre en relation avec les 2 grossesses rapprochées.

Il y a une anémie par hémodilution pendant la grossesse (cause numéro 1) → 110-120 g/L, si on est en dessous y a autre chose. Faire un bilan martial (bilan de base dans la grossesse)

HELLP : Hémolyse (LDH > 600, bili > 25, schizocytes), Elevated liver enzymes (3x la N), Low platelets (<100G/l), on verrait à partir de 20SA ?

La carence en fer n'augmente pas le risque de CS.

Il faut 3 mois pour rétablir réserve en fer, donc à administrer now pendant la grossesse.

Q4 : G2P1, 28 SA, MAP (menace d'accouchement prématuré).

R : Maturation pulmonaire dès 24SA jusqu'à 34 SA (corticoïdes).

TT en prévention pour neuroprotection du NN à risque de prématurité à 32SA = Sulfate de Mg.

Q5 : G1 34 5/7, céphalées, œdèmes des MI, TA 150/90, protéinurie.

Diagnostic : pré-éclampsie

Def : TA > 140 ou 90, associé à une protéinurie > 300mg, ou, si pas de protéinurie, signes autres (OAP, douleurs au niveau du foie, thrombopénie < 100G, CIVD...)

Q6 : 1G0P, 21 SA, TA > 160/100 (= pré-éclampsie sévère), protéinurie 700mg/24h. Première mesure ?

R : mise en place d'une perfusion IV de sulfate de magnésium = tt de pré-éclampsie. Baisser la tension avec bbloquant. Diurétiques sont CI pendant la grossesse (sauf si OAP). Ensuite on va faire la maturation pulmonaire (corticoïdes).

Décollement placentaire : pas forcément d'extériorisation de sang, risque de causer des contractions. A évaluer s'il y a un décollement (avec US), si oui on ne fait pas de tocolyse.

MgSo4 : 4g et entretien 1g/h, antidote = gluconate de calcium.

Q7 : définition pré-éclampsie

Q8 : G1, 30 SA, contractions utérines régulières et col raccourci à 1cm (MAP). Tocolyse, CI ?

R : décollement placentaire sévère et chorioamnionite (pas la RPM ni le diabète gestationnel, mais à suivre les glycémies car cortisone à un impact dessus)

Q9 : G1, 36 SA, dlrs abdo, sg frais. FC 80 bpm, TA 150/90, CTG rythme fœtal de 160/min, contractions utérines aux 5 min. Sang rouge au niveau du col et vieux dans le cul de sac vaginal. Hémorragie du 2^e semestre. Etiologie la + probable ?

R : décollement placentaire d'un placenta normalement inséré (FR : HTA) : TA haute, contraction avec utérus qui se relâche mal, sang rouge.

Placenta praevia ne fait pas mal

Rupture utérine : fait super mal, utérus ne se contracte plus, svt atcd de CS

Hémorragie de Benkiser = sg du fœtus

Début de travail = diagn d'exclusion.

Q10 : P1, contrôle à 25 SA, dépistage diabète gestationnel positif. PEC ?

R : contrôle des glycémies, tt par régime fractionné normocalorique, riche en hydrate de carbone (40-50% des calories, éviter les sucres rapides, favoriser sucres lent). Si ca ne marche pas, on pourra passer à l'insuline. Pas besoin d'hospitaliser. Repos pas bonne idée, privilégier l'AP.

HGPO : hyperglycémie par test de provocation de glucose oral (contrôle à 24-26 SA).

Q11 : G2P0, contrôle des sérologies à 10SA, présence d'IgG et IgM (= primo-infection) pour CMV (se transmet par les fluides, ex : larmes, urines... svt patient en bas âge). PEC ?

R : refaire sérologie CMV avec test d'avidité pour dater le moment de l'infection maternelle. Si on veut évaluer l'atteinte du fœtus on peut faire une amniocentèse à 20SA (attendre que le fœtus excrète le CMV dans ses urines). Infections souvent asympto.

CMV = cause principale de retard neurodev infectieuse (risque de calcification péri-ventriculaire)

Primo-infection CMV est problématique jusqu'à env 15 SA (avant grossesse et après 15 SA ca va)

Q12 : G3P2, CU régulières, BMI 35, bébé macrosome. Col utérin dilaté à 4cm, présentation céphalique à 1cm au-dessus des épines sciatiques. PEC :

R : l'expectative et l'observation de la progression de l'accouchement (tout va bien, elle a déjà accouché par voie basse, elle contracte bien...)

Indication CS > 5kg.

Manœuvre pour la dystocie des épaules = Mac-Robert ?

Q13 : A terme, travail spontané, 5 cm de dilatation. Bradycardie (< 110bpm) fœtale soudaine, persiste après tocolyse, changement de position et O2. Quelle complication de l'accouchement n'explique pas la survenue de cette bradycardie ? La on est dans une situation grave car répond pas à nos manœuvres de base.

R : compression de la veine cave (car serait résolu avec notre manœuvre de changement de position)

Bradycardie fœtal —> manœuvre de réanimation NN, mettre la patiente en décubitus latéral, ce qui stop le problème si ca vient de la veine cave.

Embolie de liquide amniotique : situation cata, bébé et maman ne vont pas bien, on peut juste réanimer la mère.

Tocolyse, utilisation :

- Diminution du risque d'accouchement prématuré
- En urgences : pendant l'accouchement, pour arrêter les CU car le fœtus peut dev un stress hypoxique

Décélération : diminution de la ligne de base < 15sec ≠ bradycardie qui dure + longtemps.

Q14 : 27 ans, CTG pathologique, cordon ombilical dans le vagin, tête fœtale 1-2 travers de doigt au dessus de la ligne interspinale et dilatation à 8cm. Procidence du cordon —> bradycardie.

R :

- Repousser la tête fœtale vers le haut et la maintenir (on ne repousse pas le cordon ombilical, on le touche pas car risque de la comprimer, on repousse la tête).
- Procéder à toutes les préparations pour une CS en urgence
- Instaurer une tocolyse d'urgence (le temps de faire la CS)

Si dilatation complète et bébé engagé : accouchement par voie basse.

Manœuvre de Kristeller : toujours faux, risque d'inversion utérine (ancienne manœuvre)

Q15 : après délivrance, face maternelle du placenta présente une érosion localisée avec du sang. Placenta paraît complet, pas de manque de cotylédon. Utérus mal contracté. Léger écoulement de sang par le vagin 15min après accouchement, perte sanguines env 800mL. PEC ?

R : administrer ocytocine.

Diagn : hémorragie du post-partum sur atonie utérine.

S'il manque un cotylédon, il faut faire une révision utérine sous péridurale (pas sous narcose).

Q16 : G2P1, accouchement à 38 SA AVB, J4 pleurt et se sent incompétente.

R : babyblues très fréquent, indication pour soutien réconfortant et bienveillant de la part de l'équipe soignante obstétricale. Ne pas psychiatriser trop tot. Dure qqes jours (svt J3 à J10), symptômes moins marqués que ceux de la dépression.

Dépression du PP : 10-15% ? des accouchement, se met en place plus tard.

Q17 : anesthésie péridurale pendant l'accouchement, après péridurale, survenue d'une bradycardie fœtale sévère (= péri-brady). Diagnostique ?

R : hypotension maternelle.

Bradycardie résolutive, donner de l'éphédrine pour remonter les tensions de la mère.

Si bradycardie toxique : la mère n'irait pas bien, acouphène, convulsions, ACR...

Q18 : G3P0, test de G+. US endovaginal, grossesse à 10SA. Comment estimer l'âge gestationnel ?

R : mesure de la longueur céphalo-caudale = LCC.

Périmètre abdominal, diamètre bipariétal et longueur fémoral utilisé pour estimer le poids du bébé plus tard dans la grossesse.

Q19 : Avortement, législation.

R : nécessite un entretien médical, puis patiente doit signer un formulaire... ?? what ?

Q20 : G2P1, 29 ans, 11 SA, risque de spina bifida, n'a pas pris d'acide folique. Dépistage pour anomalies de non fermeture du tube neural ?

R : mesure de l'alpha foetoprotéine au 2^e trimestre.

US du premier trimestre puis échographie morphologique (diagnostique).

Q21 : G2P1, 39 SA, douleurs abdo crampiformes depuis 3h, accouché par CS 3 ans auparavant, CU aux 10min, col dilaté de 2cm.

R : Évaluer possibilité d'accouchement par voie basse podalique.

Évaluation pour AVB, on fait des mesures... ?

Présentation transverse c'est la seule présentation qui nécessite une CS.

Podalique = siège.

3 atcd de CS —> CS d'emblée. 2 atcd de CS, on peut dans certaines conditions faire tentatives d'AVB.

Q22 : J1 Post-Partum d'un AVB, après déclenchement pour RPM > 24h. EF 38.5. Diagnostique ?

R : endométrite (EF, pertes vaginales malodorantes).

Partie 2

Q1 : 25 ans, cycles menstruels 40-60j (=spanioménorrhée, > 35j), désire de grossesse. Mise en évidence d'un microprolactinome non accessible à un tt chir. Traitement ?

- Agoniste de la Dopamine – Vrai
- Agoniste de la GnRH
- GnRH
- Clomifène
- Oestro-progestatif pour régulariser le cycle menstruel

Permet de bloquer l'effet inhibiteur de la PRL sur l'hypophyse sur la FSH et LH. Arrêter le tt une fois que la patiente est enceinte. Rechercher l'hyperPRL chez la femme stérile.

Agoniste GnRH : tt des fibromes utérins, endémétriose

Clomifène : anti-oestrogène (modulateur sélectif des R à l'oestrogène), déclenche l'ovulation dans le SOPK, utilisé dans l'anovulation. El : grossesse multiple si on monitore pas (guider les rapports sexuels)

Q2 : 43 ans, contrôle gynéco, dernier contrôle il y a 8 ans. Frottis dépistage du cancer du col (pap-test). Résultat : H-SIL, dysplasie marquée, suspicion de ca in situ. Démarche :

- Convoquer à 3 mois pour refaire le frottis - Faux
- Prescrire un tt local et répéter le frottis – Faux
- CT ou IRM – Faux : dans un contexte de ca du col prouvé, car sinon on verra rien, c'est des micro-lésions.
- Convoquer sans délai la patiente pour réaliser une colposcopie et des biopsies cervicales dirigées – Vrai : permettra d'avoir un diagn histologique et de proposer une attitude thérapeutique. Test au lugol pour repérer zones acidophiles ? qu'on biopsie. CIN = analyse histologique (1 à 3).
- Convoquer sans délai la patiente et lui conseiller une hystérectomie d'emblée – Faux : car si cancer plus étendu pourrait nécessiter une prise en charge différente.

Dépistage tous les 3 ans de 21 à 70 ans

- Dépistage cytologique tous les 3 ans de 21 à 29 ans
- Dépistage cytologique ou HPV de première intention tous les 3 ans de 30 ans à 70 ans

Les recommandations sont en train de changer.

Si on a un résultat ASCUS : cytologie indéterminée, alors on test pour HPV. Si + à haut risque, il faut continuer investigations

Q3 : 40 ans, hémorragies de privation régulières sous CO à prédominance gestagénique. Vous palpez une masse mobile de la région annexielle D, indolore, contours réguliers et diamètre de 10cm. US abdo : kyste multiloculaire de l'ovaire. PEC ?

- Exploration chir – Vrai : en raison de la taille et du caractère multiloculaire, permet exérèse de la masse kystique et pose le diagnostic histologique. On y associera une cytologie péritonéale.
- Frottis cytologique du col utérin avec curetage utérin explorateur
- Contrôle US dans 3 mois puis annuel pour surveiller l'évolution – Oui si masse uniloculaire de 6cm
- Traitement cytostatique
- Ni investigation complémentaire ni traitement, contrôle annuel

La plupart des kystes sont d'origine fonctionnelles (entre 15 et 50ans), nécessite seulement contrôle US tous les 3 mois, mais cut-off 8-10 cm —> indication chir car suspicion de kyste organique.

- Kystes fonctionnels : normal, va partir tout seul, les pilules ne font pas disparaître
- Kystes organiques : ne vont pas partir, tendance à grossir

Q4 : 33 ans, leucorrhée abondante depuis 4 jours, douleurs abdo basses et d'un EF autour de 38 degrés. Vous suspectez une infection génitale. Lequel des micro-organismes faut-il chercher en priorité ?

- Candida albicans
- Gardnerella vaginalis
- Chlamydia trachomatis – Vrai : germes intra-cell, 15 sérotypes, A et E causent infections génitales hautes = salpingite = PID (impact sur la fertilité et complications graves type péritonique, à distinguer des infections génitales basses). Il faut faire une PCR sur un prélèvement cervical. Chercher aussi N. gonorrhée (+/- mycoplasma genitalium).
- HSV type 2
- Bactéroïdes fragilis – Faux : n'est pas classiquement associé à des infections gynéco hautes

NB : gonocoque est à déclaration obligatoire à l'OFSP, chlamydia non.

Q5 : Chez les femmes sous oestroprogestatifs combinés, lequel de ces médicaments peut diminuer l'efficacité de la CO ?

- Anti-tussifs
- Anti-émétiques
- Glucocorticoïdes
- Anti-épileptiques – Vrai : inducteurs de CYT P450. Aussi ATB, Lithium, rifampicine
- Préparations à base de fer

Q6 : 22 ans, douleurs abdominales basses qui ont débutés il y a 3h. Douleurs grampiformes, sg plus abondant, dernières règles il y a 4 semaines, sexuellement active avec préservatif. Afébrile TA 115/65, 80 bpm. Abdomen souple sans péritonisme mais palpation profonde de la région sus-pubienne est sensible. L'examen gynéco montre présence de sang au niveau vaginal, col fermé (suggestif de fausse-couche). Palpation utérine sensible, utérus augmenté de taille, annexes normales. TG +.

- Effectuer un curetage pour une fausse-couche
- Effectuer une laparo pour une suspicion de GEU
- Demander un groupe sanguin avec rhésus et effectuer une US pelvienne – Vrai : US permet de d'être sûr que la grossesse est non évolutive avant d'aller au bloc.
- Prescrire une ATB thérapie pour une infection gynécologique haute
- Prescrire du méthotrexate pour une grossesse extra-utérine : il faut un diagnostic de certitude, pas de méthotrexate à l'aveugle (tt de la GEU), jusqu'à 5000 de betaHCG (montre l'activité de la GEU) au-delà on peut faire mais il y a plus d'échec, IM et pas d'activité cardiaque. Il faut que

la patiente soit stable, pas d'hémo-péritoine. Pas besoin d'hospitaliser la patiente mais suivi à J4 et J7, car taux d'échec de 8-11%.

Important de poser le diagnostic de fausse couche. Aspiration et curetage sont assez invasifs, on peut attendre de voir si elle expulse toute seule, ou alors traitement (misoprostol ?) qui augmente les contractions utérines.

Q7 : 28 ans, consulte pour des démangeaisons et des pertes vaginales. Sy ont débuté il y a 2 jours, en augmentation, algurie. BSH, tt par antibiothérapie il y a peu de temps pour une sinusite. Status : érythème et œdème vulvaire associé à des leucorrhées abondantes. Examen direct montre des pseudo-hyphes. PEC :

- Lavage vaginal par ampicilline
- Biopsie vulvaire
- Azithromycine orale
- Traitement topique de clotrimazole - Vrai : antifongique local par imidazolés, traitement par ovule pendant 3j et crème pendant 7-10j.
- Traitement de métronidazole topique = flagyl, utilisé pour les vaginoses bactériennes (contre les anaérobies).

Q8 : 58 ans, bouffées de chaleur (= vasodilatation) apparues il y a 6 mois en augmentation récente, survient à diff moment de la journée, plus intenses la nuit. Dernières règles il y a 7 mois, atcd d'EP et de syndrome dépressif sous sertraline et fume un paquet par jour. Status sp. La phytothérapie n'a produit aucun effet. Traitement :

- Clonidine – Vrai : traitement anti-hypertenseur utilisé avec succès en cas de bouffées de chaleur liées à la ménopause. Agoniste alpha-adrénergique d'action centrale. Switch par Efexor aurait pu être discuté. —> contrôler la TA.
- Oestrogène et progestérone – Faux : car elle a trop de CI (EP, tabac)
- Oestrogènes seuls – Faux : risque de ca de l'endomètre si on complète pas avec des progestérone
- Raloxifène (= SERM) – Faux : traitement de l'ostéoporose qui peut aggraver les bouffées de chaleur
- Tamoxifène – Faux : occasionnellement prescrit mais pas tt de choix

TT ménopause :

- Acupuncture et phytothérapie
- Oestrogènes (si pas d'atcd ni risque de ca du sein)
- Efexor, clonidine

Q9 : 72 ans, consulte pour un prurit vulvaire qui s'aggrave depuis 3 ans, traité par anti-fongique qui marche pas. Pas eu de sg depuis ménopause apparue à l'âge de 54 ans. Fume un paquet/j. Examen vulvaire : présence d'une lésion ulcérée de la grande lèvre G de 2cm. Attitude :

- Biopsie de la lésion vulvaire – Vrai : présentation classique d'un ca épidermoïde vulvaire, on doit faire un diagnostic histologique est indispensable. FR = lichen scléro-atrophique et HPV.
- Vulvectomie d'emblée – Faux : sauf si suspicion d'un mélanome de la vulve (ça se voit visuellement par le dermato)
- ATB thérapie à large spectre
- Crème à base de stéroïdes : le lichen scléro-atrophique = maladie auto-immune très fréquente qui donne un prurit de la vulve mais ne se présente pas sous cette forme (blanc, nacré, aspect ivoire, disparition des reliefs vulvaires et prurit important), il se traite par crème à base de stéroïdes.

- Référer à un psy - Faux : c'est un diagnostic d'exclusion

Q10 : 31 ans, douleurs abdo depuis 36h et spotting. Pas d'Atcd médico-chir. Date des dernières règles inconnue. T 37 degrés, TA 116/78, 82 bpm. Abdomen souple et indolore. Présence de sang en faible quantité au niveau vaginal, col fermé. Sensibilité à la palpation bimanuelle. Labo ne montre pas de leuco...

- CT – Faux : risque ionisant, être bien sur que beta hCG soit neg
- ASP
- ECG
- Dosage sanguin des hCG – Vrai : à faire avant l'US, meilleure sensibilité en sanguin.
- US pelvien

Rappel : indice de Pearl pour efficacité de la contraception

Q11 : 16 ans, inquiète de ne pas encore avoir eu ses règles (aménorrhée primaire). Pas de pb médical, n'a pas encore eu de rapport sexuel. Sa mère et sa sœur ont eu leurs premières règles à l'âge de 13 ans avec des cycles réguliers. TA 110/70. Aucune douleur abdo. Mesure 155 cm pour 49 kg (absence de retard statural). Seins de dev normal, pilosité pubienne et axillaire normale pour son âge. Cause d'aménorrhée primaire la + probable :

- Dysfonction hypothalamique – Faux : car on n'aurait pas les caractères sex 2nd
- Imperforation hyménéale – Faux : elle présenterait des douleurs abdominales cycliques, et à terme un hématoocolpos, urgence ped
- Dysfonction hypophysaire – Faux : pareil que pour dysfonction hypothalamique
- Sy de R aux androgènes – Faux : aurait d'autres signes (pilosité ?)
- Malformation utéro-vaginale – Vrai : agénésie utérine et vaginale (sy de Rokitanski, atteint 1 fille sur 4000) se présente souvent de cette manière avec des caractères sexuels 2nd normaux. Il y a une cupule vaginale, impossibilité d'avoir des rapports sex et stérilité. TT : greffe utérine ou grossesse pour autrui (GPA). Accouchement par CS car vagin pas fonctionnel, à 32 SA car patiente ne sent pas le bébé. Si patiente ne veut plus de grossesse on peut enlever la greffe (max 2 grossesses).

Q12 : 26 ans, BSH, consulte pour une dysménorrhée sévère évoluant depuis 6 mois. Pas de métrorragies. Ménarche remonte à l'âge de 14 ans, cycles réguliers. Elle se traite par AINS, peu efficace. Rapports sex protégés. Afébril, examen pelvien est normal. US endovaginal est sp à l'exception d'un kyste ovarien D. L'anamnèse est évocatrice de :

- Endométriose – Vrai : 10% des femmes, souvent pendant la période d'activité génitale, dysménorrhée 2nd. Pathologies multi-systèmes qui peut atteindre plrs organes. 4D : dysménorrhée, dyspareunie, dyschésie (douleurs à la défécation +/- rectorragie si envahissement important), dysurie (aussi macro-hématurie). Si 2 des 4 symptômes, il faut évoquer une endométriose. Peut entraîner une endométriose de l'ovaire (= endométriome). Théorie du reflux ? reste d'actualité mais n'explique pas toutes les atteintes.
- Endométrite
- Infection gynécologique haute
- Rupture de kyste ovarien – Faux : symptômes plus soudains et l'US montre en général la présence de liquide libre intra-abdo
- Fibrome utérin

Test salivaire est pas encore remboursé, 700 francs. Micro-ARN salivaire.

Q13 : 32 ans, hyperménorrhée depuis 3 mois associées à des métrorragies occasionnelles. Pas de dysménorrhée, pas de douleurs abdo. Depuis l'âge de 14 ans, elle a des cycles réguliers.

Anémie microcytaire hypochrome. Crase normale. L'origine la plus probable :

- Saignements sur cycles anovulatoires – Faux : SOPK donne des cycles anovulatoires
- Coagulopathie
- Hyperplasie de l'endomètre
- Polype endométrial – Vrai : polypes endométriaux ou myomes sous-muqueux se présentent habituellement par des hyperménorrhées et des métrorragies. Il faut faire une polypectomie.
- Fausse couche - Faux : mais faire quand même un TG pour être sur

Classification PALM-COEIN pour les saignements utérins anormaux :

- Polyp
- Adénomyose
- Léiomyome
- Malignancy et hyperplasie

- Coagulopathie (maladie de Von Willebrand)
- Ovulatory dysfunction
- Endometrial
- Iatrogenic
- Not identified

Q14 : 37 ans, 4G4P, qui consulte pour demande de contraception. Souhaite un moyen de contraception sûr et le plus naturel possible. Souffre de BPCO sur tabagisme, fume 2 paquets/j depuis 14 ans. Elle n'a pas d'atcd chirurgical. Elle a une relation stable avec son conjoint depuis 10 ans. Le status est sans particularité. Quel moyen de contraception proposez-vous en première intention ?

- Préservatifs – moins fiable
- Stérilet – Vrai : fiable, indiqué chez patiente sans facteurs de risque infectieux pour une durée prolongée (5 ans)
- Infection de Dépo-provera (medroxyprogestérone) tous les 3 mois – Faux : risque de déminéralisation osseuse et d'ostéoporose
- Contraception orale par oestro-progestatifs : CI chez patiente fumeuse de > 35 ans
- Ligature tubaire – opération sous AG, elle a des FR pour l'anesthésie (BPCO)

Vasectomie : 700.-, non réversible, moins de risque.

Q15 : 22 ans, nulligeste, consulte en urgences suite à une rupture de préservatif. Ne veut pas être enceinte. On propose :

- Contraception d'urgence : max 72h après un TS non protégé (nom du médicament ?). Pose d'un stérilet aussi possible.
- Implant contraceptif : non, pas en urgence

Q16 : 65 ans, métrorragies intermittentes depuis 3 semaines. Ménopausée depuis 53 ans, sous traitement de fluoxétine pour état dépressif. Examen clinique sp, traces de sang au niveau vaginal, d'origine cervical. Pas de masse utérine ou pelvienne palpable.

- Pessaire
- Biopsie de l'endomètre (pipelle de Cornier) et un frottis cervico-utérin – Vrai : ça de l'endomètre est fréquent, diagn c'est US et biopsie.
- Traitement par oestrogènes - Faux : ça de l'endomètre est hormon-dep, il faut l'exclure avant

- Rassurer la patiente en lui disant que ce type de sg est normal
- Proposer une hystérectomie – Faux : il faut d'abord poser le diagn

Q17 : 55 ans, masse femre dans le sein G, pas d'écoulement mammaire. Poids stable. Ménopausée depuis l'âge de 50 ans sans traitement hormonale de substitution. Nodule ferme de 2cm de diamètre dans le sang au niveau du QSE du sein G, mobile et régulier. Peau en regard sp, pas de gg palpable au niveau axillaire. Mammographie non conclusive en raison des seins très denses. PEC :

- Biospie échoguidée de la lésion – Vrai : suspicion de néoplasie, besoin d'un diagnostic histo
- Réassurance et mammographie à 6 mois
- Réassurance et mammographie + US à 1 an
- Réassurance et contrôle clinique à 6 mois
- Recherche des mutations BRCA1 et 2 – Pas d'anamnèse évocatrice d'un syndrome familial, ce n'est pas la priorité

Ca du sein : 1/7 femme dans sa vie

Q18 : 16 ans, douleurs abdo, a vomi 1x, pas de plaintes urinaires, pas de leucorrhées. Dernières règles remontent à 2 semaines. EF 38.9 degrés. Abdomen non péritonitique, fosses iliaque G et D sont sensibles, mobilisation du col douloureuse, palpation bimanuelle des annexes douloureuse, surtout à D. Examen direct révèle nombreux leucocytes. TG neg. Quel élément parle le + en faveur d'une infection génitale haute ?

- Sensibilité en fosses iliaques D et G
- Palpation annexielle et mobilisation cervicale douloureuse – Vrai :
- Fièvre à 39 degrés
- Absence de trouble urinaire
- Présence de leucocytes à l'examen direct

PID :

- Critères majeurs
 - o Douleurs pelviennes spontannées
 - o Douleurs annexielle provoquée et/ou douleur à la mobilisation utérine
- Critères mineurs

Q19 : 25 ans, aménorrhée secondaire depuis un an, auparavant cycles réguliers depuis l'âge de 13 ans. Jamais été enceinte. Très sportive, vient de participer au marathon. Pas de galactorrhée. Taux de PRL normal. Taux de ? ... TG neg. Cause probable :

- Origine hypothalamique – Vrai : entraînement physique intensif donne un hypogonadisme hypothalamique d'origine fonctionnel associé à des signes de carence oestrogénique.
- Tumeur hypophysaire – Faux : peu probable car PRL normal
- SOPK
- Ménopause précoce
- Utilisation prolongée d'un stérilet